

产后康复治疗仪低频脉冲电疗法对产后子宫恢复的影响

张丽萍

赣南医学院第二附属医院妇产科 (江西信丰 341600)

〔摘要〕目的 探讨产后康复治疗仪低频脉冲电疗法对产后子宫恢复的影响。方法 选取 2018 年 4 月至 2019 年 6 月医院收治的 50 例产妇为研究对象,按照随机数字表法分成两组,各 25 例。对照组采用常规方法进行产后康复治疗,试验组在对照组的基础上采用产后康复治疗仪低频脉冲电疗法进行治疗,比较两组治疗后血性恶露量、宫缩疼痛持续时间、恶露持续时间以及两组产后 24 h、72 h、5 d 的宫底高度。结果 试验组血性恶露量少于对照组,宫缩疼痛持续时间和恶露持续时间均短于对照组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。试验组产后 24 h、72 h、5 d 的宫底高度均低于对照组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论 产后康复治疗仪低频脉冲电疗法有助于降低产妇的产后恶露量,缩短宫缩疼痛持续时间和恶露时间,从而加快子宫恢复。

〔关键词〕产后康复治疗仪; 低频脉冲电疗法; 子宫恢复; 治疗效果

〔中图分类号〕 R714.14 **〔文献标识码〕** B **〔文章编号〕** 1002-2376(2020)08-0122-02

产妇分娩后生理上发生了巨大的变化,加上心情紧张、焦虑等不良心理的影响,易造成产后子宫复旧不良、排尿不畅及乳汁分泌不足等,严重影响产妇和新生儿的安全和健康^[1]。低温脉冲电疗是临床常用的康复理疗设备,主要是运用蜗形磁场穿透至深层组织内,加速局部组织运动,促进组织张力缓解,加速毛细血管收缩,改善血液循环,是目前促进产妇康复的一种有效方法^[2]。本研究旨在探讨产后康复治疗仪低频脉冲电疗法对产后子宫恢复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2018 年 4 月至 2019 年 6 月我院收治的 50 例产妇为研究对象,按照随机数字表法分成两组,各 25 例。对照组经产妇 14 例,初产妇 11 例;年龄 21~35 岁,平均 (27.13 ± 3.39) 岁;孕周 37~41 周,平均 (38.56 ± 1.05) 周。试验组经产妇 13 例,初产妇 12 例;年龄 21~36 岁,平均 (27.23 ± 3.52) 岁;孕周 37.5~41 周,平均 (38.55 ± 1.02) 周。两组一般资料比较,差异无统计学意义 ($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法

对照组采用常规方法进行产后康复治疗:加强对产妇的健康宣教,指导早期饮食、子宫按摩以及早期运动,并教会产妇母乳喂养的方法。

试验组在对照组的基础上给予产后康复治疗仪低频脉冲电疗法治疗:产妇在产后使用低频脉冲综合治疗仪 JLT-D,接通电源,选择“子宫复旧模块”和“温热模式”;频率为 833 Hz,脉冲宽度为 0.4 ms,脉冲强度自 0 Hz 开始,逐渐增加,直到产妇耐受为宜,最大不超过 250 Hz;让产妇取平卧位,常规清洁和消毒皮肤区域,将耦合剂涂抹在 4 个温热的导电片上,之后将其交叉放置在消毒的皮肤区域(或将温热电贴片交叉旋转放置在前后背腹部或骶骨两侧),注意避开伤口处,将箭头指向“子宫恢复”,治疗 25 min/次,2 次/d,连续治疗 7 d;在治疗过程中应密切注意产妇的情况,观察有无头痛、皮肤疼痛、胸闷等症状,及时调节脉冲强度。

1.3 临床评价

(1) 记录治疗后两组的宫缩疼痛持续时间、恶露持续时间。(2) 采用面积法测量血性恶露量:浸湿两层敷料的面积来估算,如 5 cm×5 cm 计血量 2 ml;10 cm×10 cm 计血量 5 ml;15 cm×15 cm 计血量 10 ml 等。(3) 测量两组产后 24 h、72 h、5 d 的宫底高度。采用软尺沿腹中线测量耻骨联合上缘中点到子宫底之间的距离。

1.4 统计学处理

采用 SPSS 23.0 统计软件进行数据分析,计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,采用 t 检验,计数资料以率表示,采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗后血性恶露量、宫缩疼痛持续时间及恶露持续时间比较

试验组血性恶露量少于对照组,宫缩疼痛持续时间和恶露持续时间均短于对照组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$),见表 1。

表 1 两组治疗后血性恶露量、宫缩疼痛持续时间及恶露持续时间比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	血性恶露量 (ml)	宫缩疼痛持续时间 (d)	恶露持续时间 (d)
对照组	25	193.75 ± 40.82	2.98 ± 0.73	193.75 ± 40.82
试验组	25	155.85 ± 30.44	2.01 ± 0.32	155.84 ± 30.44
t		3.722	6.085	3.722
P		0.000	0.000	0.000

2.2 两组产后 24 h、72 h、5 d 的宫底高度比较

试验组产后 24 h、72 h、5 d 的宫底高度均低于对照组,差异有统计学意义 ($P < 0.05$),见表 2。

表 2 两组产后 24 h、72 h、5 d 的宫底高度比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	产后 24 h	产后 72 h	产后 5 d
对照组	25	12.48 ± 1.76	9.76 ± 1.79	8.79 ± 1.57
试验组	25	10.62 ± 1.25	8.93 ± 1.38	6.12 ± 1.23
t		4.308	1.836	6.694
P		0.000	0.036	0.000

3 讨论

产妇在分娩过程往往需要消耗巨大的精力和体力,同时承受着剧烈的疼痛,导致其心理和生理出现了一系列应激反

收稿日期: 2019-09-17

— 122 —

真方白丸子治疗风痰入络型急性期脑梗死患者的临床效果

张丽丽

凌源市中医院住院处内五科 (辽宁凌源 122500)

【摘要】目的 探讨真方白丸子治疗风痰入络型急性期脑梗死患者的临床疗效。**方法** 选取 2017 年 11 月至 2018 年 11 月收治的 112 例风痰入络型急性期脑梗死患者, 随机分为两组, 各 56 例。对照组采取常规治疗, 试验组在对照组的基础上加用真方白丸子治疗, 比较两组治疗前后血清神经元特异性烯醇化酶 (NSE)、白介素-1 (IL-1)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 水平及临床疗效。**结果** 试验组治疗后 NSE、IL-1、TNF- α 分别为 (8.99 $\pm$ 2.35) μ g/L、(10.35 $\pm$ 2.51) ng/ml、(17.63 $\pm$ 5.49) ng/ml, 对照组治疗后 NSE、IL-1、TNF- α 分别为 (14.26 $\pm$ 3.03) μ g/L、(18.15 $\pm$ 2.46) ng/ml、(25.41 $\pm$ 4.37) ng/ml, 试验组治疗后 NSE、IL-1、TNF- α 水平下降明显优于对照组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。试验组总有效率 (94.6%) 明显高于对照组 (85.7%), 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。**结论** 真方白丸子治疗风痰入络型急性期脑梗死患者效果确切, 且可降低血清 NSE、IL-1、TNF- α 水平。

【关键词】 真方白丸子; 风痰入络型; 急性期脑梗死

【中图分类号】 R743 **【文献标识码】** B **【文章编号】** 1002-2376 (2020) 08-0123-02

随着老龄化社会的到来, 心脑血管疾病已成为严重的公共卫生问题, 资料显示, 2016 年全球死于心脑血管疾病的人数占总死亡人数的 1/3, 患者数量达 1760 万^[1]。急性脑梗死是常见的脑血管疾病, 中医称“中风”。急性脑梗死患者病死率高、致残率高, 关于本病的治疗目前尚无突破性进展。急性脑梗死患者治疗的主要原则是急性期抢救半暗带区, 稳定病情, 改善神经功能; 稳定期通过长久的康复功能训练减轻或消除后遗症, 恢复日常生活能力。脑梗死的疾病负担十分严重。中医治疗急性脑梗死患者具有较好的效果, “整体

性”原则为其增加了“多靶点”的治疗优势。由于中药方剂灵活多变, 目前尚缺乏统一标准, 用药的规范性、临床疗效及安全性方面仍需大量研究加以证实。真方白丸子方具有祛风化痰通络的功效, 本研究旨在探讨真方白丸子治疗风痰入络型急性期脑梗死患者的临床效果, 现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2017 年 11 月至 2018 年 11 月我院收治的 112 例风痰入络型急性期脑梗死患者, 随机分为两组, 各 56 例。对照组男 31 例, 女 25 例; 年龄 47~79 岁, 平均 (58.93 $\pm$ 7.25) 岁; 试验组男 33 例, 女 23 例; 年龄 46~77 岁, 平均 (57.12 $\pm$ 9.14) 岁。

综上所述, 产后康复治疗仪低频脉冲电疗法有助于加速产后恶露排出, 减轻宫缩疼痛, 促进产后子宫恢复。

参考文献

- [1] 陈彩虹. 产后康复治疗仪对产妇康复的效果评价 [J]. 当代医学, 2018, 24 (13): 83-84.
- [2] 陈添翠, 韦素芬. 低频电脉冲刺激对促进产后产妇产后子宫复旧的临床观察 [J]. 中国民康医学, 2017, 29 (5): 24-26.
- [3] 秦广华. 产后康复治疗仪低频脉冲电疗法对产后子宫复旧的疗效观察 [J]. 双足与保健, 2018, 27 (18): 23-24.
- [4] 李建茹, 王桂英. 产后康复数控治疗仪对剖宫产患者促进乳汁分泌的影响 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, 18 (60): 299.
- [5] 郑艺娟. 低频脉冲治疗仪对促进产后催乳及子宫复旧的疗效观察 [J]. 医疗装备, 2017, 30 (20): 128.
- [6] 孔庆坤, 孙婉婷. 超声脉冲电导治疗仪用于产后康复护理的临床研究 [J]. 中国卫生标准管理, 2017, 8 (4): 142-143.
- [7] 邱玉玲. 产后康复治疗仪使用时机对促进子宫收缩及刺激泌乳的效果观察 [J]. 蛇志, 2017, 29 (2): 172-173.
- [8] 何庆凤, 何映娴, 张春燕. 低频脉冲对经产妇产后子宫恢复水平的影响 [J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2017, 38 (8): 991-992.

收稿日期: 2019-09-24

应, 可能造成各种健康问题。子宫复旧不良是产妇产后最为常见的健康问题, 有可能引发产后出血, 因此产后加强预防和护理对促进产妇产后子宫恢复有积极意义^[2]。既往传统治疗宫缩痛的方法是主要是通过抑制前列腺素的合成与释放, 进而达到减轻产妇产后疼痛的目的, 但是往往疗效不佳, 且易引起泌乳不足、胃肠道反应等多种不良反应^[3]。

低频脉冲治疗能够直接作用于产妇的骶尾部, 从而加速产妇产后盆底的血液循环, 并加快局部水分吸收; 低频治疗还可促使盆腔筋膜与肌肉规律运动, 从而增强胃动力, 加速盆腔内淤血消失, 加速产后恶露排出, 促进产后子宫快速复旧^[4-6]。本研究结果显示, 试验组血性恶露量少于对照组, 宫缩疼痛持续时间和恶露持续时间均短于对照组, 试验组产后 24 h、72 h、5 d 的宫底高度均低于对照组 ($P < 0.05$)。本研究结果与邱玉玲^[7]的研究结果相似, 表明产妇产后接受低频脉冲电疗可显著减轻宫缩痛, 并有助于加快恶露排出, 促进子宫恢复。另外还有研究表明, 产妇在产后使用低频脉冲治疗仪进行康复治疗还可有效疏通乳腺管和促进泌乳, 有助于提高母乳喂养成功率, 而有效的母乳喂养也会加速子宫复旧, 诱导产妇及时排尿, 从而减轻尿潴留^[8]。